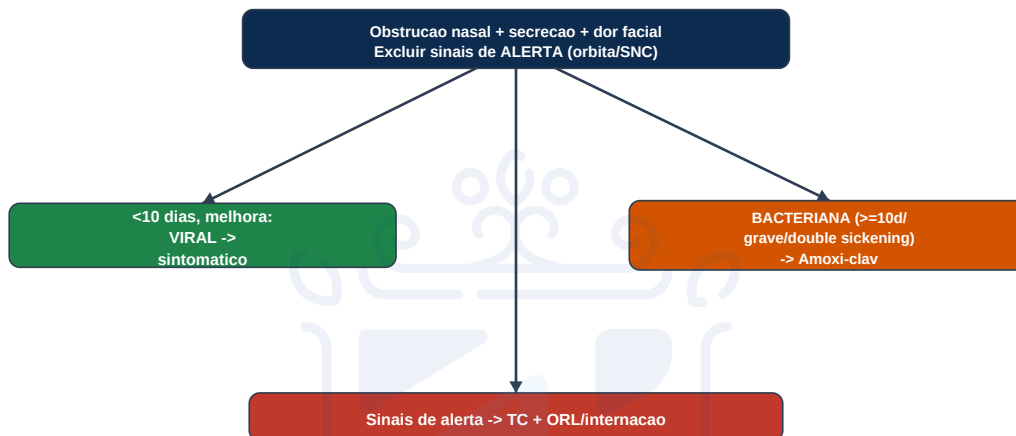


RINOSSINUSITE AGUDA — VIRAL x BACTERIANA

FLUXOGRAMA — VIRAL x BACTERIANA

RINOSSINUSITE — O TEMPO E O PADRÃO DECIDEM



DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

O QUE É

- Inflamação da mucosa nasal e dos seios paranasais: obstrução nasal, secreção, dor facial, cefaleia
- Viral (resfriado comum) | Bacteriana aguda | Crônica (> 12 semanas)
- Patógenos bacterianos: *S. pneumoniae*, *H. influenzae*, *M. catarrhalis*
- Fatores predisponentes: rinite, desvio de septo, adenoides, exposição a mofo/cigarro

VIRAL x BACTERIANA — CRITÉRIOS

Viral	Bacteriana (um dos 3 critérios)
Sintomas < 10 dias	Sintomas persistem >= 10 dias SEM melhora
Secreção clara/mucopurulenta	Sintomas graves desde o início: febre >= 39 + secreção purulenta por >= 3 dias
Melhora progressiva após 5-7 dias	Piora após melhora inicial ('double sickening', 5-7 dias)

RED FLAGS — COMPLICAÇÕES ORBITÁRIAS/INTRACRANIANAS

AValiação IMEDIATA + IMAGEM

- Edema ou eritema PERIORBITÁRIO (celulite orbitária)
- Proptose ocular ou alteração da movimentação ocular; diplopia ou alterações visuais
- Edema frontal (Sinal de Pott / osteomielite frontal — 'Pott's puffy tumor')
- Sintomas neurológicos: cefaleia intensa, vômitos, rebaixamento, sinais meníngeos
- Esses sinais exigem TC de seios da face/órbitas e avaliação ORL/neurocirurgia

TRATAMENTO

Rx VIRAL x BACTERIANA

VIRAL: sintomático — analgésico/antitérmico, lavagem nasal com SF 0,9% 4-6x/dia, hidratação

BACTERIANA (1a linha): Amoxicilina +/- Clavulanato

Pediatria: amoxi-clav 80-90 mg/kg/dia VO 12/12h por 10-14 dias

Adultos: amoxi-clav 875/125 mg VO 12/12h por 10-14 dias

Falha/casos graves: amoxi-clav (se ainda não usado) ou Ceftriaxona 50-100 mg/kg/dia IM/EV por 3-5 dias

Lavagem nasal com SF 0,9% como adjuvante em todos

QUANDO PEDIR EXAMES

TC E LABORATÓRIO

- TC de seios da face: suspeita de complicação orbitária/intracraniana
- febre alta persistente com toxemia; sintomas graves refratários; sintomas neurológicos
- sinusite crônica/recorrente (> 4 episódios/ano) para planejamento cirúrgico
- Hemograma: se suspeita de complicação bacteriana/sepsse
- PCR e VHS: se toxemia/febre persistente. Não necessários em casos não complicados

CHECKLIST DE ALTA

ANTES DE LIBERAR

- ☐ Melhora clínica documentada; sinais vitais estáveis
- ☐ Sem sinais de complicação (face, olhos, neurológico); ausculta pulmonar sem piora
- ☐ Receita explicada (importância de completar o antibiótico); técnica de lavagem nasal demonstrada
- ☐ Retorno se: febre após 3 dias de ATB, piora, inchaço/vermelhidão em rosto/olhos, cefaleia intensa, vômito, alteração visual
- ☐ Orientar fatores de risco (cessar tabagismo, controle ambiental); seguimento se recorrente

MODELO DE TRANSFERÊNCIA (complicada)

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Rinossinusite há ____; secreção ____; dor facial em ____; febre ____.
- Sinais de complicação: edema periorbitário / proptose / alteração visual / sinais neurológicos.
- Conduta: ATB ____, analgesia, lavagem nasal. TC de seios: ____.
- Solicito TC de urgência / avaliação ORL-neurocirurgia / UTI conforme complicação.

Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Paciente com obstrução nasal e secreção purulenta há 4 dias, em melhora progressiva. Conduta?

- A) Antibiótico imediato
- B) Tratamento sintomático (provável rinossinusite viral)
- C) Tomografia de seios da face
- D) Ceftriaxona endovenosa
- E) Corticoide oral por 10 dias

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual critério sugere rinossinusite BACTERIANA aguda?

- A) Sintomas há 3 dias melhorando
- B) Sintomas persistentes ≥ 10 dias sem melhora, ou febre ≥ 39 com secreção purulenta ≥ 3 dias, ou 'double sickening'
- C) Secreção clara
- D) Espirros isolados
- E) Sintomas há 5 dias com melhora

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual achado indica complicação grave da sinusite e necessidade de TC urgente?

- A) Espirros
- B) Edema periorbitário, proptose ou alteração visual
- C) Coriza clara
- D) Dor maxilar leve
- E) Cefaleia leve isolada

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Qual é o antibiótico de primeira linha na rinossinusite bacteriana aguda?

- A) Azitromicina
- B) Amoxicilina ($\pm$ clavulanato)
- C) Ciprofloxacino
- D) Clindamicina
- E) Vancomicina

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

O edema frontal com abaulamento (Sinal de Pott / 'Pott's puffy tumor') indica:

- A) Rinite alérgica
- B) Osteomielite do osso frontal — complicação grave que exige imagem e avaliação especializada
- C) Conjuntivite
- D) Resfriado comum
- E) Otite externa

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Sintomas há < 10 dias com melhora progressiva caracterizam rinossinusite viral; o tratamento é sintomático (lavagem nasal, analgesia). Antibiótico só se preencher critérios de etiologia bacteriana.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Suspeita-se de bacteriana se um dos três: sintomas ≥ 10 dias sem melhora; quadro grave inicial (febre ≥ 39 + secreção purulenta ≥ 3 dias); ou piora após melhora inicial ('double sickening').

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Edema periorbitário, proptose, alteração da motilidade/acuidade visual e sinais neurológicos indicam complicação orbitária/intracraniana, exigindo TC de seios/órbitas e avaliação ORL/neurocirurgia urgentes.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

A amoxicilina (com ou sem clavulanato) é a primeira linha na rinossinusite bacteriana aguda; ceftriaxona fica para falha/casos graves. Macrolídeos e quinolonas não são primeira escolha.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

O edema frontal flutuante (Sinal de Pott / 'Pott's puffy tumor') traduz osteomielite do osso frontal por sinusite frontal complicada — emergência que requer imagem e manejo especializado.

SM24
Suporte ao Plantão Médico